

Modyfikuj korzeń — *traumatyczne wspomnienia ciała*

Komentarze rodziców, bullying, „żarty” o ciele — wczesne wspomnienia jako korzeń nadwartościowania. Imagery rescripting modyfikuje znaczenie emocjonalne.

CZAS: 60–90 min na sesję, 3–8 sesji na wspomnienie

REALIZACJA: zaawansowana faza CBT-E / Schema, po stabilizacji

ŹRÓDŁO: Arntz & Weertman (1999, *Behav Res Ther*); Cooper (2017); Pennesi & Wade (2018, ED imagery)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **typowe wspomnienia** ciała w AN (komentarze rodziców, bullying, „żarty”, upokorzenie w szkole) + mechanizm imagery rescripting. Sekcja 02 — **pięć kroków protokołu**: identyfikacja, ekspozycja, modyfikacja, integracja. Sekcja 03 — **arkusz wspomnień**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Imagery rescripting (Arntz & Weertman, 1999) — technika modyfikacji znaczenia emocjonalnego traumatycznych wspomnień przez wyobrażeniowe „przepisanie” sceny. W AN: pacjenci często mają wczesne, intensywnie emocjonalne wspomnienia związane z ciałem — komentarze rodziców („*masz tłuste uda*”), upokorzenia w szkole (przebieranie, lekcje WF), bullying, „żarty” rówieśników, ocena pierwszej intymności. Te wspomnienia są *kotwicą* nadwartościowania — emocjonalnym korzeniem, z którego wyrasta lęk. Cooper (2017): praca z imagery *zmniejsza* nasilenie nadwartościowania w sposób, w jaki czysta CBT poznawcza często nie potrafi. Mechanizm: wyobrażone przepisanie sceny (wsparcie, ochrona, mądrość dorosłego) modyfikuje znaczenie emocjonalne, nie fakt historyczny.

01 Typowe wczesne wspomnienia ciała w AN

TYP WSPOMNIENIA	PRZYKŁADY I ZNACZENIE EMOCJONALNE
<i>Komentarze rodziców</i>	„Masz tłuste uda”, „nie jedz tego, przytyjesz”, „ojciec mówił, że Twoja siostra jest ładniejsza”. Często powtarzane przez lata. Tworzą podstawowe przekonanie: „moje ciało nie jest OK”.
<i>Bullying rówieśniczy</i>	Przezwiśka („gruba”, „chuda”, „słoń”), wykluczenie z grupy, „żarty”, przebieranie na lekcjach WF. Często w wieku 9–13 lat. Korzeń wstydu społecznego ciała.
<i>Upokorzenie w szkole/sporcie</i>	Komentarze nauczyciela („X jest za gruba, żeby skoczyć przez kozła”), porównania w grupie, fotografie klasowe. Wstyd publiczny + bezsilność.
<i>Pierwsze doświadczenia intymności</i>	Ocena ciała przez partnera, odrzucenie, niechciana uwaga, doświadczenia molestowania. Korzeń lęku przed intymnością + checking/avoidance ciała.
<i>Komentarze lekarzy</i>	„Musisz schudnąć 5 kg”, „BMI za wysoki” (wypowiedziane bez kontekstu). U pacjentów z atypową AN: lekarz, który <i>pochwalił</i> spadek wagi, zanim okazał się patologiczny.

Imagery rescripting modyfikuje znaczenie, nie fakt. Nie udajemy, że coś się nie wydarzyło. Modyfikujemy emocjonalne znaczenie wspomnienia — wprowadzając do sceny ochronę, walidację, mądrość, których wtedy zabrakło.

02 Pięć kroków protokołu (Arntz & Weertman, 1999)

1. **Identyfikacja wspomnienia źródłowego** — pytanie diagnostyczne: „Kiedy po raz pierwszy poczułaś/-eś, że Twoje ciało jest „nie OK”? Co się wtedy wydarzyło? Kto był? Co powiedział/zrobił?” Wspomnienie powinno być żywe i emocjonalnie wciąż obecne.
2. **Ekspozycja na wspomnienie** — pacjent z zamkniętymi oczami opisuje scenę w pierwszej osobie, w czasie teraźniejszym: „jestem w klasie, mam 11 lat, słyszę jak X mówi...” Terapeuta pyta o szczegóły zmysłowe: co widzisz, słyszysz, czujesz w ciele, jaki masz dostęp emocjonalny.
3. **Identyfikacja potrzeby** — „Czego potrzebowałaś/-eś wtedy? Ochrony? Wsparcia? Słów, które ktoś powinien był powiedzieć?” Pacjent nazywa, czego zabrakło.
4. **Rescripting — przepisanie** — terapeuta prowadzi: „Wyobraź sobie, że teraz wchodzisz do tej sceny — jako dorosły/-a, kim jesteś dzisiaj. Stajesz obok 11-letniej/-ego siebie. Co mówisz? Co robisz?” Pacjent aktywnie chroni/wspiera siebie z przeszłości. Alternatywa: wprowadza opiekuna, mądrego dorosłego, terapeutę.
5. **Integracja** — po sesji rozmowa o emocjach i nowym znaczeniu. „Co czujesz teraz wobec tej sceny? Co zmieniło się w tym, jak ją pamiętasz?” Powtarzanie sesji 3–8 razy zanim wspomnienie traci „kotwiczne” działanie.

03 Arkusz wspomnień ciała — do wypełnienia z terapeutą

NAJWCZEŚNIEJSZE WSPOMNIENIE, KIEDY POCZUŁEŚ/-AM, ŻE MOJE CIAŁO JEST „NIE OK”

— wiek, miejsce, kto był, co powiedział/zrobił

CO KONKRETNIE POCZUŁEŚ/-AM WTEDY

— wstyd, lęk, gniew, bezradność; gdzie w ciele to się działo

CZEGO POTRZEBOWAŁEŚ/-AM WTEDY, ALE NIE DOSTAŁEŚ/-AM

— ochrony, walidacji, słów, że jesteś OK, że to nie Twoja wina

CO DZIŚ DOROSŁY/-A TY POWIEDZIAŁBY/-ABY TAMTEMU DZIECKU

— do wykorzystania w rescriptingu na sesji

Klucz: imagery rescripting to zaawansowana technika — wymaga stabilności pacjenta (medycznie i emocjonalnie), bezpiecznego przymierza terapeutycznego i kompetencji terapeuty w prowadzeniu imagery. Nie dla pacjentów w ostrym kryzysie. Pennesi & Wade (2018): imagery w ED znacząco redukuje nadwartościowanie, gdy CBT poznawcza osiąga stagnację (ang. *plateau*). **Komunikat dla pacjenta:** „nie cofamy czasu, nie zmieniamy tego, co się stało. Modyfikujemy znaczenie emocjonalne wspomnienia — wprowadzając do niego ochronę, której wtedy zabrakło. Wspomnienie traci „kotwiczne” działanie”.

⚠ **Praca z traumą wymaga ostrożności:** u pacjentów z C-PTSD lub historią ciężkiej traumy (np. molestowanie) imagery rescripting może uruchamiać silne reakcje. Konieczne: psychoedukacja okna tolerancji, techniki uziemienia (ang. *grounding*), plan po sesji, niekiedy konsultacja z trauma-specjalistycznym terapeutą. Imagery nie jest pierwszym narzędziem — wprowadza się po stabilizacji.